Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral

Unidad 5. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación: clasificación, descripción y etiología

UNIDAD 5

Unidad 5. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación: clasificación, descripción y etiología

ÍNDICE

1. Introducción....4

2. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación 4

2.1. Introducción....4

2.2. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación (I) 7

2.2.1. Retraso específico o simple del lenguaje (REL o RSL).... 7

2.2.1.1. Conceptualización, manifestación y características.... 7

2.2.1.2. Niveles lingüísticos afectados.... 8

2.2.1.3. Evaluación.... 8

2.2.1.4. Intervención.... 10

2.2.2. Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).... 12

2.2.2.1. Conceptualización y prevalencia 12

2.2.2.2. Problemas terminológicos.... 12

2.2.2.3. Etiología, neurobiología y dificultades asociadas.... 13

2.2.2.4. Signos de alerta por componente del lenguaje.... 14

2.2.2.5. Evaluación.... 16

2.2.2.6. Intervención.... 18

2.3. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación (II) 21

2.3.1. Mutismo selectivo 21

2.3.1.1. Conceptualización, manifestación y características.... 21

2.3.1.2. Pautas y orientaciones educativas 21

2.3.2. Afasia infantil 22

2.3.2.1. Conceptualización.... 22

2.3.2.2. Afasia infantil adquirida: características principales.... 23

2.3.2.3. Afasia infantil adquirida: taxonomía 23

.... 23

2.3.2.4. Evaluación estandarizada de la afasia infantil adquirida 24

2.3.2.5. Intervención de la afasia infantil adquirida.... 24

2.4. Enfermedades raras desde el marco de AL. 26

BIBLIOGRAFÍA.....228

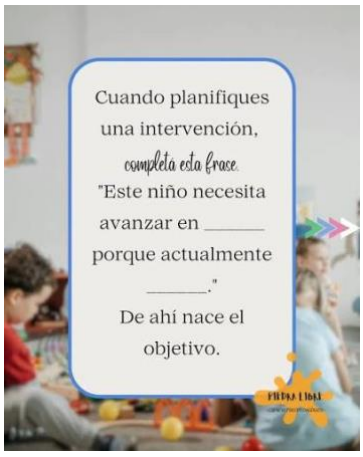
Anexo: Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL): una infografía básica actualizada. (Palazón, 2023). 31

1. Introducción

Las patologías del lenguaje oral son heterogéneas y engloban a un grupo muy diverso de alteraciones de su desarrollo, genéticas o adquiridas, caracterizadas principalmente por un déficit en la comprensión, producción y uso del lenguaje. La diversidad en la etiología, las manifestaciones clínicas, el pronóstico y el tratamiento, junto a la alta frecuencia (10-15% en menores de 6 años) hace que la atención a los niños que las presentan suponga un reto para los profesionales implicados (Barragán y Lozano, 2011).

Desde la publicación del DSM-5-TR, algunas de las patologías del lenguaje, el habla y la comunicación se incluyen para su catalogación diagnóstica dentro de los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, es decir, se consideran trastornos del neurodesarrollo cuando comienzan a una edad temprana, pues pueden producir limitaciones significativas en el desarrollo del individuo y no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial, a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica (Aguilera y Busto, 2012).

Tomando como referencia lo anterior, en esta unidad se proporcionarán características y claves diagnósticas principales de los trastornos del lenguaje, así como, estrategias e indicaciones sobre su evaluación, pronóstico y orientaciones para profesores tutores y padres.



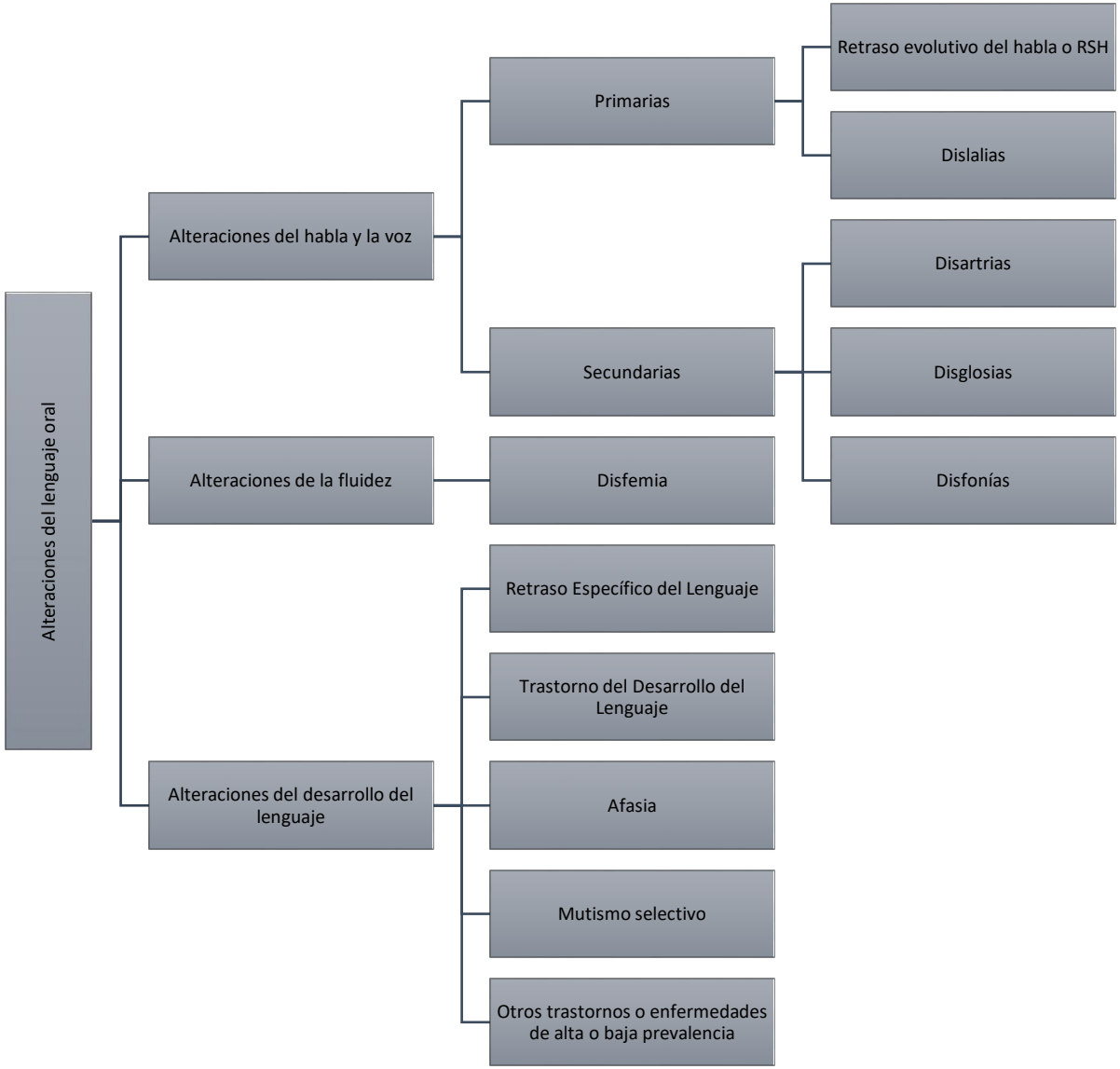
2. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación

2.1. Introducción

Todos los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación tienen consecuencias graves para la cognición cognitivo sociabilidad del niño. En este sentido, será vital conocer cuáles son los más prevalentes (véase Figura 1) para conseguir que su detección, evaluación e intervención sean eficaces (Susanibar et al., 2016)

Figura 1.

Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral (Susanibar et al., 2016)



2.2. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación (I)

Los trastornos que se pueden presentar en este ámbito, son muchos y variados, pueden afectar a uno, a varios o a todos los componentes del lenguaje, difieren en su etiología, en el pronóstico, en las necesidades educativas que generan y en la respuesta educativa que requieren (Benasich y Tallal, 2002).

Estos trastornos se dan formando un continuo que iría, desde el retraso simple del lenguaje hasta la perdida total de las capacidades lingüísticas en el caso de la afasia. Otro importante aspecto a resaltar, es el diferente pronóstico que cada uno de los tipos de trastorno tiene (Aguilar-Mediavilla et al., 2014)). En este sentido, es importante señalar la gran variabilidad de terminología, la cual va a depender del enfoque que dan las distintas escuelas y el modelo de explicación del lenguaje que cada una utiliza.

2.2.1. Retraso específico o simple del lenguaje (REL o RSL)

2.2.1.1. Conceptualización, manifestación y características

Alteración en la que existe un desfase cronológico entre el lenguaje del niño y lo esperado según la edad, sin que exista un déficit intelectual, sensorial o motriz que lo justifique. Suele diagnosticarse entre los 2 y 6 años, que es la edad en que el niño ya ha iniciado el aprendizaje del lenguaje (Aguilera y Busto, 2012).

En este trastorno, el lenguaje se va adquiriendo más tarde de lo normal, pero en el orden habitual, es decir, *se desarrolla por los cauces normales, pero más lentamente*. En lo que respecta a sus características, entre las más destacables, según Mejía-Rodríguez (2015), se encuentran:

- Primeras palabras suelen aparecer a los 24 meses en lugar de al año, que es lo más frecuente. La unión de 2 palabras no comienza antes de los 3 años.
- Lenguaje telegráfico. Preferencia por la comunicación con gestos.
- La comprensión parece mejor que la expresión, aunque ambas estén afectadas. En el caso de la primera, sobre todo si el enunciado es largo o ambiguo. El niño comprende más de lo que habla, así, por ejemplo, si se le dice que señale algo lo hace, o lo muestra, pero no dice el nombre del objeto.
- Escasa o nula repercusión sobre el aprendizaje del lenguaje escrito.
- Su núcleo sintomatológico está en el trastorno de la fonología con una afectación más o menos grave de la sintaxis y su factor causal en un retraso de maduración.
- Los problemas de emisión de sonidos y vocabulario son los más llamativos.El vocabulario es escaso y se reduce a las cosas familiares de su entorno. Al ser éste más

limitado se hace más difícil construir las primeras frases. Esto hace que le cuesten las relaciones con otros niños.

- El niño comprende las cuestiones concretas y familiares ("dame la pelota") pero pueden tener lagunas en los conceptos más abstractos (espacio-temporales) o en comprender frases que hacen referencia a algo que no está presente ("¿cuando vas de viaje?").

2.2.1.2. Niveles lingüísticos afectados

Siguiendo a Artigas et al. (2008), generalmente se produce un desfase cronológico en una o más áreas del lenguaje, resultando especialmente destacables las alteraciones en relación con la fonética-fonología y la sintaxis, pero sin dejar atrás el vocabulario y la pragmática.

- En su nivel fonético-fonológico tienen un habla infantilizada con procesos de simplificación del habla, realizando palabras monosílabas y bisílabas con estructura C-V y básicamente utilizando los fonemas /m/, /p/ y /t/.
- En su nivel léxico-semántico suelen tener poco vocabulario y les cuesta adquirirlo sobre todo en conceptos abstractos.
- En el nivel morfosintáctico de normal realizan frases desorganizadas, cortas con dificultades en el uso de artículos, pronombres, plurales y conjugaciones verbales, además del uso continuado de la conjunción ``y´´ cuando realizan subordinadas.
- En el nivel pragmático tienen poca intencionalidad comunicativa, predomina la función reguladora del lenguaje y el nombramiento de objetos. Además, no relatan acontecimientos y tienden a compensar sus dificultades con gestos.

2.2.1.3. Evaluación

Dado que son varias las razones por las cuales se debe valorar el lenguaje en el RSL (el habla es un indicador del desarrollo integral del niño; para detectar las dificultades en este proceso; para determinar los niños en riesgo y para evaluar el progreso del niño) y que es difícil realizar una valoración objetiva por medio de la observación espontánea, se hace necesario el diseño de escalas estandarizadas que permitan tener una referencia del grado de desarrollo del niño con respecto al lenguaje utilizado, la actividad motriz capaz de desplegar, el aspecto social, etc., en una determinada edad.

Dichas escalas estandarizadas evalúan, generalmente, conductas motrices, sociales, adaptativas y del lenguaje, de manera integral y general. En el terreno español existe, teniendo en cuenta lo anterior, un amplio abanico de pruebas *(véase Figura 2)*.

Figura 2.

Escalas estandarizadas para la evaluación del RSL (Mejía-Rodríguez, 2015)



En caso de ser detectado un posible caso de RSL, la demanda suele partir del profesor tutor o de los padres y, en base a ella, se debe empezar por observar al niño en el aula ordinaria y en los espacios de juego y recreo.

Tras esa observación, se pasará a mantener una entrevista con los padres, a poder ser en presencia del tutor, en la que se solicitará autorización para la evaluación mientras se recaba información relevante. La evaluación del alumno y su posterior diagnóstico, gracias a la estandarización, será competencia de otros profesionales.

El profesional de AL deberá hacer hacer un seguimiento de las posibles dificultades que puedan existir. *Su papel* será importante dado que va a poder detectar los problemas que el alumnado presenta y, a partir de esta detección, proporcionar datos fiables y válidos a los demás profesionales encargados de su evaluación clínica. Además, podrá controlar, posteriormente, la eficacia de los programas implantados y pruebas aplicadas.

Siguiendo a Albesa y Ayala (2017), desde el punto de vista clínico, la evaluación del lenguaje consiste básicamente en una historia clínica logofoniátrica (Anamnesis, examen clínico-funcional del lenguaje, habla y voz, examen del lenguaje extraverbal, examen físico de los órganos fonoarticulatorios) y, como ya se mencionó, la aplicación de una batería de test

estandarizados con lo cual se obtiene la información del perfil comunicativo del niño en todas sus áreas (fonología, gramática, semántica, funcionalidad del lenguaje, habilidades previas…):

- Habilidades previas: respiración, exploración de los órganos bucofonatorios, su funcionalidad a partir de praxias orolinguofaciales, discriminación auditiva, lateralidad, esquema corporal, nociones espaciales y temporales, atención y memoria, relajación global y segmentaria.
- Aspecto fonológico: se evaluará la articulación mediante la utilización de un RFI que permitirá evaluar la conciencia fonológica, repetición de sílabas, palabras y frases, la voz (tono, timbre, intensidad,…) y la fonación, la prosodia, la inteligibilidad de su habla y su coordinación fonorespiratoria.
- Aspecto gramatical: se analizará la morfología nominal y verbal, así como los elementos preposicionales y adverbiales, junto con los nexos. Se evaluarán mediante preguntas dirigidas al alumno, descripciones de objetos y denominaciones. Se utilizarán diálogos para evaluar la estructuración sintáctica que utiliza en sus producciones orales y la concordancia y estructura verbal.
- Aspecto semántico: dentro de este apartado se evaluará el nivel de vocabulario expresivo del que dispone el alumno, se hace referencia al conocimiento de las relaciones que se establecen entre significados, poniéndose en juego las capacidades de categorización y clasificación que nos permiten organizar la realidad.
- Funcionalidad del lenguaje oral como medio de comunicación del pensamiento: expresión espontánea ante una lámina y expresión espontánea ante una actividad manipulativa (rompecabezas).
- Comprensión verbal: el objetivo es evaluar el nivel de léxico comprensivo del sujeto a través de tareas de designación, sin que se halle implicada una respuesta verbal:
- Aspecto semántico: se evaluará el nivel de vocabulario receptivo del alumno.
- Aspecto analítico-sintético: se evaluará si comprende órdenes sencillas y complejas.
- Aspecto del pensamiento: se evaluará por medio de preguntas sobre objetos, situaciones, etc.

2.2.1.4. Intervención

En la intervención en RSL, la estimulación lingüística y el desarrollo comunicativo-lingüístico deben de realizarse de una forma adaptada a las características concretas del niño (Barrágan y Lozano, 2011), pues se ha comprobado que una estimulación del lenguaje, adecuada a las condiciones del niño y su contexto, contribuye al desarrollo del aprendizaje.

En los casos de RSL, lo más efectivo, al ser una población escolar de riesgo, es el diseño de programas preventivos de estimulación del lenguaje induciendo, mediante estímulos comunicativos y verbales naturales, y exponiendo a los niños a un entorno accesible.

Como ya se ha mencionado, en el RSL el pronóstico es positivo, distinguiéndose así de otras alteraciones lingüísticas. Sin embargo, si no hay una detección temprana o la intervención de las dificultades no es la adecuada, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede verse alterado.

Al hablar de estimulación en niños con RSL, tal y como apuntan Albesa y Ayala (2017), se debe tener en cuenta si es de carácter clínico o lingüístico. En lo que respecta al segundo, propiamente función del especialista en audición y lenguaje, se debe actuar tomando como referencia los niveles o áreas del lenguaje: fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Intervención en áreas del lenguaje de los sujetos con RSL (Magdalena, 2020)

Nivel o área del lenguaje	Carácterísticas de la intervención
Fonología	Los niños con R.S.L muestran patrones fonológicos desviados, su habla suele ser infantilizada y la estructura silábica es simple. Un elemento clave a trabajar al respecto es la conciencia fonológica, especialmente en lenguas fonológicamente transparentes como es el castellano, antes de aprender a leer o escribir los niños adquieren léxico auditivo. Es importante trabajar el progreso de la destreza para secuenciar los sonidos para lograr un lenguaje adecuado y una buena asimilación de la lectura y la escritura.
Morfosintaxis	Los alumnos con R.S.L presentan un lenguaje con una desorganización en la sucesión normal de la oración (el lenguaje presenta un aspecto telegráfico). El número de conceptos que nombran en la frase es reducido, teniendo dificultades en el manejo de artículos, pronombres, plurales y en el uso de diferentes tiempos verbales. Por estos aspectos será necesario que en el aspecto morfosintáctico trabajemos con los niños la expansión gramatical, es decir mejorar el empleo de elementos sintácticos y gramaticales (plurales, pronombres, verbos etc.) así como la estructura de las oraciones teniendo presente la edad del niño y la secuencia evolutiva de las mismas.
Semántica	El vocabulario en niños con R.S.L está normalmente mermado, basándose en objetos del entorno más cercano, también se pueden distinguir en ellos dificultades para la asimilación de conceptos abstractos, como colores, formas y tamaños o nociones espacio-temporales. Es importante trabajar la ampliación de vocabulario y la

	mejora de las relaciones léxicas entre dicho vocabulario.
Pragmática	Poseen dificultades en torno a la intención comunicativa, el lenguaje básicamente es utilizado para nombrar y conseguir objetos, así como para estructurar la conducta. Los niños con R.S.L muestran dificultades para aplicar cualidades a objetos y articular preguntas. Se inclinan a apoyar sus exposiciones verbales con excesiva mímica y gestos para compensar las carencias expresivas. Lo primordial en esta dimensión del lenguaje que se debe trabajar son las funciones y usos del lenguaje, así como las habilidades conversacionales que permitan desarrollar su lenguaje oral.

Los niños con RSL con menor afectación, pueden pasar desapercibidos fácilmente, dejando pasar tiempo en la intervención, tiempo de especial valor para el desarrollo de sus habilidades (Monfort et al. 2004).

2.2.2. Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL)

2.2.2.1. Conceptualización y prevalencia

Trastorno del neurodesarrollo que se da cuando existen dificultades para hablar o entender el lenguaje y que se caracteriza porque los sujetos presentan un vocabulario reducido, deficientes construcciones morfosintácticas y alteraciones significativas del discurso que generan limitaciones en la participación social, la comunicación y el desempeño académico (Ahufinger er al., 2021).

Habitualmente, se suele detectar desde los 4 años y posee una prevalencia del 7,58% . No obstante, las diferencias metodológicas en el diagnóstico, los instrumentos de evaluación o los criterios de cohorte empleados, no permiten confirmar con certeza su prevalencia exacta (Hincapié et al., 2008).

2.2.2.2. Problemas terminológicos

Lo primero sobre lo que debe tratarse en este punto es la novedad en cuanto a la terminología referida al trastorno. Como docentes, independientemente del campo de especialidad, se debe conocer la distinción existente entre trastorno específico del lenguaje (TEL), trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) y trastorno del lenguaje (TL).

En relación con lo anterior, el Consorcio Catalise (2017), como se publicó en los artículos de Bishop et al. (2016, 2017), aconseja utilizar las siglas TDL para designar al trastorno severo y persistente en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral que no está asociado a una condición médica, que puede involucrar a uno o varios componentes del lenguaje en diferente

grado, tanto a nivel expresivo como receptivo, y que afecta al desarrollo social y escolar. La denominación TEL queda, por tanto, sustituida.

Por su parte, tal y como señalan Ahufinger et al., (2021), se hablará de TDL cuando se presenten dificultades severas y persistentes en el desarrollo del lenguaje y estas se encuentren asociadas con una condición biomédica X (i.e., trastornos neurodegenerativos, daño cerebral, parálisis cerebral, hipoacusia neurosensorial, síndromes genéticos, autismo, discapacidad intelectual), ya que se necesitará de una intervención que vaya más allá de las dificultades del lenguaje y que se centre también en las otras áreas del desarrollo en las que impacta esa condición .

Así pues, el TDL es un trastorno que presenta gran heterogeneidad y complejidad, dado su multivariado grado de afectación en una o varias en dimensiones del lenguaje como sintaxis, morfología, semántica, acceso al léxico, pragmática, discurso, aprendizaje verbal/memoria o fonología .

2.2.2.3. Etiología, neurobiología y dificultades asociadas

En relación con su etiología, tal y como menciona Magdalena (2020), a pesar de los avances en estudios de neurociencia, la comprensión de esta alteración es todavía limitada y, por tanto, su etiología también:

- Dificultades para manejar secuencias de sonidos a la misma velocidad en la que se dan en el habla.
- Dificultades para retener e identificar en el almacén fonológico segmentos muy breves de la cadena hablada, construir representaciones y recuperarlas por medio de la cadena hablada.
- Limitaciones en memoria fonológica a corto plazo (marcador fenotípico de discriminación).
- Dificultades en la repetición de pseudopalabras (requiere la capacidad de retener cadenas de sonidos del habla desconocidos durante breves periodos de tiempo).
- Velocidad de procesamiento lenta tanto en tareas lingüísticas como no lingüísticas.
- Dificultades en la memoria procedimental y en la adquisición de habilidades automáticas: gran debate y poca evidencia.

Por su parte, en términos de neurobiología, en la mayoría de casos no hay evidencia de ningún daño cerebral; puede que haya diferencias sutiles en cuanto a la medida de diferentes regiones y proporciones de la materia gris del cerebro, pero hay muchas diferencias de un

niño/ a otro/a. A día de hoy no tenemos ningún "biomarcador" para el TDL (Muñoz-López y Carballo-García, 2005).

Finalmente, en lo que respecta a las dificultades que se asocian a esta alteración, Los niños con TDL tienen más probabilidad de tener problemas sociales, emocionales, de conducta y de adquisición de los aprendizajes:

- El TDL se suele manifestar con el TDAH y la dislexia. Ha habido mucho debate sobre el solapamiento con el TEA (Bishop y Leonard, 2001).
- Conductas conflictivas o dificultades de relación.
- Dificultades de comportamiento, incluyendo hiperactividad y dificultades de atención.
- Reticencia conductual como retraimiento, cautela y timidez.
- Dificultades para regular las emociones (monitorización, evaluación o modificación de reacciones emocionales).
- Baja autoestima social y riesgo de intimidación.

2.2.2.4. Signos de alerta por componente del lenguaje

El TDL compromete de manera selectiva el lenguaje durante las fases evolutivas del desarrollo en niños que no tienen alteración macroscópica de tipo neurológico o sensorial evidente. Este trastorno se presenta en las etapas iniciales del desarrollo y a pesar de compartir características principales tanto en el aspecto comprensivo como de producción del lenguaje, su perfil es de carácter heterogéneo (Bishop y Leonard, 2001).

Las habilidades lingüísticas de este alumnado no pueden ser concebidas como sistemas autónomos, sino que todos los niveles están interrelacionados. En este sentido, por ejemplo, tal y como señalan Barragán y Lozano (2011), presentarán mayores problemas para producir determinadas estructuras gramaticales cuando tales producciones requieren excesivas demandas fonológicas, sobre todo aquellos rasgos que se encuentren asociados a los procesos fonológicos comunes (i.e., omisión de la consonante final, reducción de grupos consonánticos, omisión de la sílaba átona etc.). Este efecto en cascada entre ambos dominios lingüísticos da cuenta de que el incremento en uno tiene una consecuencia considerable sobre otros.

Tal y como señalan Muñoz-López y Carballo-García (2005), a pesar de que el alumnado con TDL tiene un desarrollo aparentemente normal en dominios no lingüísticos, presenta dificultades en la adquisición del lenguaje expresivo, manifestándose así alteraciones en la fonología en algún momento de su desarrollo. A lo anterior se añade que las escasas vocalizaciones, verbalizaciones y oportunidades para la práctica vocal pueden explicarse porque desarrollan una conducta de evitación fonológica, consecuencia de su escasa habilidad para interaccionar.

Asimismo, poseen un inventario fonético reducido, un repertorio consonántico poco preciso y unas estructuras silábicas de carácter simples, lo cual deriva en una aparente obstaculización a la hora de establecer representaciones fonológicas adecuadas (Lopera, 2008).

En lo que respecta a las *alteraciones gramaticales,* consideradas uno de los marcadores más fiables del TDL, el alumnado presenta dificultades tanto en el reconocimiento de los tiempos verbales como en la validación de los marcadores que los acompañan, lo cual no puede ser explicado por sus déficits relacionados con bajos niveles de percepción auditiva, pues aquellos que presentan hipoacusia media o moderada no tienen dificultades para adquirir la morfología verbal ni presentan problemas de comprensión sintáctica (Hincapié et al., 2008).

Por otro lado, Benasich y Tallal (2002) apuntan que puede observarse la continua sustitución de unas formas gramaticales por otras de la misma categoría, sobre todo entre las conjunciones, preposiciones, artículos o pronombres, y las grandes limitaciones en el uso de morfemas relacionados con frases de sustantivo (i.e., pronombres clíticos de OD, inflexiones de sustantivo plural e inflexiones en la concordancia de adjetivos), en las cuales se omiten o sustituyen unas formas por otras que se parecen a la forma correcta en casi todas sus características (i.e., tiempo y número correctos pero no persona). Por su parte, los morfemas de género y número suelen estar bien establecidos cuando se refieren a las palabras e incluso cuando se utilizan en las oraciones simples, apareciendo así las dificultades en oraciones más complejas a la hora de respetar las reglas de concordancia (Morán et al., 2017).

Con respecto a las *alteraciones en sintaxis,* los problemas se manifiestan principalmente en oraciones negativas, imperativas, pasivas, interrogativas y, más aun, en las coordinadas y subordinadas. Estos errores conducen a que, en una situación comunicativa, un alumno emplee oraciones poco explícitas, estructuras rígidas, pobres y, al mismo tiempo, ambiguas y desestructuradas. El nivel de expresión sintáctica del alumnado con TDL puede ser un predictor importante de sus habilidades de lenguaje posteriores (Norbury et al., 2001).

En relación con las *alteraciones en el léxico,* Weismer et al., (2000) hacen referencia a la existencia de numerosas investigaciones que dan cuenta de que, en el desarrollo de esta dimensión, el alumnado con TDL tiene una ejecución inferior a su edad. Por consiguiente, la adquisición y el uso apropiado de palabras nuevas será un proceso complejo dado que tendrán que identificar tanto la forma hablada como el significado correcto a partir de su experiencia lingüística y deberán hacerlo sin un entrenamiento directo. Además, cuentan con una capacidad de procesamiento limitada cuando se les presentan estímulos verbales y no verbales con rapidez.

Por su parte, los *déficits semánticos* se extienden más allá de sus problemas con el tamaño del vocabulario, hecho que da cuenta de que la evaluación semántica no debe centrarse exclusivamente en medidas de tamaño de vocabulario receptivo y expresivo. En primer lugar, los déficits en el tamaño del vocabulario no son predictores de las habilidades de lenguaje posteriores y, en segundo lugar, el alumnado con dificultades del lenguaje a menudo presenta alteraciones con otras áreas semánticas, tales como las habilidades para establecer relaciones complejas dentro y entre las palabras (Mendoza y Muñoz, 2001).

En torno al campo de las *alteraciones en pragmática y en discurso,* debe mencionarse que sobre el primero podrán observarse dificultades para el uso o comprensión del lenguaje en un contexto determinado, categoría en la que se pueden incluir aspectos como ofrecer mucha o poca información, o por ejemplo ser demasiado literal al comprender (Adams, 2003). En lo referido al segundo, cabe destacar que es importante que el alumnado con TDL sepa agrupar de manera ordenada y correcta secuencias de enunciados, para que lo que transmitan tenga significado completo, de tal manera que, si esta dimensión se ve afectada, puede suponer grandes dificultades a nivel, por ejemplo, de narración (Magdalena, 2020).

Por último, en relación con las dificultades relacionadas con el aprendizaje verbal y la memoria, debe hacerse referencia a los numerosos problemas que posee este alumnado para retener en la memoria a corto plazo las formas fonológicas de las palabras nuevas, para conservar parte o toda la información fonológica que se requiere para aprender nuevos términos y morfemas, para memorizar durante breves periodos de tiempo (MCP) secuencias de sonidos o palabras o, por ejemplo, para asociar el aprendizaje de las palabras con el significado de estas (Lum et al., 2012).

Así pues, todo lo mencionado anteriormente da prueba de que, dado que es un trastorno que afecta al proceso cognitivo del lenguaje, se manifiesta durante los años preescolares en contextos conversacionales y se extiende a lo largo del tiempo, tanto en la comprensión como en la producción, de estructuras literales en el lenguaje oral y escrito, genera en quien lo presenta un marcado impacto tanto social como educativo (Hincapié et al., 2008).

2.2.2.5. Evaluación

La población con TDL presenta diferentes perfiles de déficits de lenguaje y severidad, es decir, sus habilidades lingüísticas presentan alteraciones a nivel de procesamiento del lenguaje, dependiendo del nivel lingüístico (fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico o pragmático) o de la modalidad de lenguaje utilizada (comprensión y/o producción), que pueden estar selectivamente comprometidas (Poyuelo y Rondal, 2005).

Esta realidad, implica buscar pruebas de lenguaje que midan las variables antes descritas y tengan un nivel de sensibilidad y especificidad altos (véase Figura 3).

Figura 3.

Pruebas estandarizadas TDL (Montull, 2020)

Pruebas para la detección del TDL			
Nombre	**Edad**	**Duración**	**Explicación**
PLON-R	3-6 años	10-12 minutos	Permite evaluar el desarrollo del lenguaje oral y valorar aspectos como la fonología, morfosintaxis, contenido y uso del lenguaje
CELF Preescolar	3- 6:11 años	15-20 minutos	Mide las habilidades del lenguaje receptivo y expresivo
CEG. Test de Comprensión de estructuras gramaticales	4-11, versión infantil a partir de los 2 años	15-20 minutos	Permite evaluar la comprensión gramatical de los niños/as.
ITPA. Test de Illinois de Aptitudes Psicosociales	3-10 años	60 minutos	Permite detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de comunicación y permite conocer los puntos fuertes
TSA. El Desarrollo de la morfosintaxis en el niño	2-7 años	10 minutos	Permite evaluar el desarrollo morfosintáctico, la comprensión y la producción lingüística
PEABODY. Test de Vocabulario en Imágenes	2-90 años	10-20 minutos	Permite evaluar el nivel de vocabulario receptivo y detectar la presencia de dificultades en la aptitud verbal

En lo que respecta a los test no estandarizados, tal y como menciona Montull (2020), existen numerosos de gran validez en la evaluación del lenguaje, pero, entre ellos, destacan los siguientes:

- Producción verbal espontánea. Registro y transcripción de muestra.
- Producción verbal evocada. Análisis de aspectos del lenguaje que no aparecen en el habla espontánea.
    - Tareas de expresión de relatos mediante la presentación de láminas o escenas que desencadenan la producción verbal.
    - Tareas de organización lógica y de explicación de una historia (viñetas ordenadas o desordenadas).
    - Tareas de completar frases, de incitación al diálogo, de interpretación de refranes, fábulas o expresiones idiomáticas.
    - Ejercicios de lógica verbal.
    - Tareas de negaciones semánticas y sintácticas, sustitución de palabras, de incrementación de un texto.

- Comprensión. Es preciso responder a tres tareas:
    - Definir una respuesta adecuada que implique con absoluta certeza la comprensión de la expresión emitida.
    - Especificar la naturaleza de la tarea de evaluación y las exigencias que impone el niño.
    - Especificar los estímulos lingüísticos que se van a emplear
- Imitación provocada. Consiste en pedir al niño que repita una serie de palabras o frases dichas.

Aunque el proceso de evaluación sea largo y, en ocasiones ambiguo, a la hora de detectar la alteración se deben seguir, como exponen Roselli et al. (2010), siempre distintas frases:

- Detección de la alteración.
- Determinación del estado de las conductas.
- Evaluación en el contexto del programa de intervención.

Una vez se haya tomado la decisión de llevar a cabo una evaluación, el maestro de AL debe prestar atención a los contenidos fundamentales que esta debe tener:

- Bases anatómicas y funcionales en las que se tendrá en cuenta tanto el aparato fonador como la audición.
- Dimensiones del lenguaje, es decir, la forma del lenguaje, el contenido que hay en el lenguaje o el uso-función que se hace de este.
- Procesos por los que pasa el lenguaje, tales como comprensión, producción, lectoescritura o el desarrollo cognitivo.

2.2.2.6. Intervención

La intervención en el lenguaje con un alumno con TDL, no se podría llevar a cabo de manera satisfactoria, si primero no se interviene en los tres factores básicos cognitivos, como son la atención, la percepción y la memoria.

En lo que concierne a las estrategias que se deben tener en cuenta para el aula cuando en ella se encuentre alumnado con TDL, primero se hará referencia a aquellas estrategias generales enfocadas a la productividad del proceso de enseñanza-aprendizaje (ATELGA, 2014):

- Reforzar positivamente el esfuerzo y aportar seguridad al alumnado.
- Emplear apoyos visuales para paliar sus dificultades de comprensión y organización.
- Guías de autoinstrucción de organización personal, de tareas, de exámenes, etc.
- Adecuación del volumen de trabajo a las habilidades del alumnado y favorecer la comunicación bidireccional.

- Control de la comprensión de explicaciones, tareas y procesos mediante la aportación de feedback comprensivo y autoevaluación oral.
- Diseñar dinámicas encaminadas a garantizar el aprendizaje simultáneo, evitando la repetición y favoreciendo la compensación.
- Potenciar la organización autónoma y el aprendizaje tanto individual como cooperativo.
- Incorporar variedad y, poco a poco, complejidad para permitir un aprendizaje en engranaje.
- Asegurar la frecuencia de contenidos y la cantidad, es decir, se demandará más planificación.
- Desarrollar y potenciar las dinámicas ABP para reducir la complejidad, aumentar la motivación y mejorar la comprensión.

Ríos-Flórez y López-Gutiérrez (2017) añaden a las anteriores una serie de estrategias específicas que deben aplicarse específicamente en el aula con alumnado con TDL:

- Desarrollar estrategias de lectura comprensiva. Uso del contexto para deducir el significado de una palabra, activación del conocimiento previo, relectura de textos, uso de autocuestionarios, visualización del contenido a través de técnicas como el visual thinking.
- Implementar estrategias para establecer el orden de prioridad que ayuden al alumnado a organizar todos los componentes de la lectura, planificar ideas de qué hacer y cómo hacerlo, así como la evaluación y la revisión.
- Ampliar vocabulario en actividades interrelacionadas de escucha, habla, lectura y escritura.
- Desarrollar estrategias de parafraseo. Esta estrategia ayudaría a desarrollar la capacidad morfosintáctica e implicaría ofrecer muchos ejemplos sobre como las palabras y las oraciones pueden cambiar para retener el significado.
- Proporcionar siempre soporte visual para mejorar la capacidad cognitiva. Se deben combinar las herramientas analógicas y digitales, pues se ha demostrado que su combinación mejora las habilidades lingüísticas en sujetos con TDL (Washington y Genese, 2013; en Polo y Acuña, 2018).
- Usar dibujos para ayudar a la comprensión de términos y verbos que tienen marcadores para los componentes gramaticales, y el uso de formas o símbolos de color codificados.

- Elaborar diccionarios visuales para trabajar la ortografía arbitraria y el enriquecimiento de vocabulario.

Por su parte, Polo y Acuña (2018) inciden en la importancia de la mejora de la comprensión lectora y por ello consideran de vital importancia:

- Ofrecer textos equilibrados en tamaño y complejidad con vocabulario habitual.
- Exponer las ideas específicas y generales tras la lectura y ofrecer información previa sobre el texto antes de leerlo.
- Emplear pictogramas y utilizar, en caso de necesidad, la adaptación a Lectura Fácil.

Finalmente, en relación con las estrategias para el diseño de actividades y pruebas de evaluación, es conveniente tener una actitud positiva frente al niño, reforzándolo positivamente y felicitándole ante sus progresos, poniendo en marcha las pautas descritas a continuación (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Estrategias para el diseño de actividades y pruebas de evaluación del alumnado con TDL en el aula (Polo y Acuña, 2018)

Estrategias para el diseño de actividades y pruebas de evaluación del alumnado con TDL en el aula
Realización de preguntas cerradas sin dar lugar a inferencias.
Empleo de preguntas de selección múltiple con respuesta dicotómica y no politómica. Diseño de preguntas de verdadero/falso y, también, de preguntas de respuesta corta, pues el alumnado con TDL puede tener dificultades para organizar las ideas y planificar lo que debe escribir, así como también para escribir frases gramaticalmente correctas.
Fomentar los ejercicios de asociación imagen y palabra, sobre todo a la hora de practicar la semántica.
A la hora de redactar, creación de boxes que deban rellenar, creación de guiones etc. De modo que pueda tener una organización clave para el desarrollo de lo que quiera expresar.
Destaque de palabras claves en los enunciados. Ampliación del tamaño de letra y el interlineado para favorecer una presentación clara y limpia
Complementación siempre del material con apoyos visuales para favorecer el trabajo. Establecimiento del orden de actividades de mayor a menor complejidad.
Hacer uso de la representación y verbalización de Scripts para estimular el uso de unidades lingüísticas como vocabulario, verbos, adjetivos, pronombres, preposiciones, elaboración de frases o formulación de preguntas.
Diseño de actividades que permitan la categorización de conceptos y familias léxicas junto con la distinción de palabras en distintos tipos de oraciones. Asimismo, incluir apartados dedicados a la conciencia metafonológica y la asociación Grafema-Fonema.

2.3. Alteraciones del desarrollo del lenguaje y la comunicación (II)

2.3.1. Mutismo selectivo

2.3.1.1. Conceptualización, manifestación y características

Rechazo persistente a hablar en una o más situaciones sociales, incluyendo la escuela, a pesar de la capacidad para hablar y comprender el lenguaje hablado. Es poco frecuente (un 1 por 100 de la población). Con frecuencia, se manifiesta al iniciar la escolaridad, aunque ha podido empezar con anterioridad. Solo se puede hablar de él cuando persiste más allá de los 6 años de edad y produce trastornos escolares (Oerbeck et a., 2018).

Entre sus características principales destacan, tal y como señala López (2019):

- Deterioro de la adaptación escolar y social del niño y dificultades relacionales.
- Nula interacción verbal con compañeros de clase e incluso con los demás miembros de la comunidad educativa o familia.
- Elevados niveles de ansiedad social e inhibición conductual.

2.3.1.2. Pautas y orientaciones educativas

Las tareas fundamentales del maestro de AL serán, por una parte, la de establecer una vinculación afectiva positiva con el niño que le aporte la seguridad suficiente para enfrentarse a las situaciones, y por otra parte, la de diseñar y planificar actividades de clase que requieran de una comunicación verbal (Medeiro y Larraguibel, 2018):

- Para mejorar las condiciones personales y sociales:
    - Posibilitar en las dinámicas del aula la planificación y el diseño de actividades en grupo.
    - Evitar la sobreprotección.
    - Asignar pequeñas tareas de responsabilidad dentro del aula y del centro educativo ajustadas a la edad.
    - Aumentar el control del adulto en la interacción escolar con el fin de evitar el aislamiento del alumno.
    - Incrementar dentro de la programación de aula las actividades que impliquen contacto físico entre los niños.
    - Crear un clima de seguridad, aceptación y confianza en el aula favorable a la comunicación verbal. Introducir actividades de relajación de forma habitual.
- Para la estimulación del habla:

- Buscar y compartir momentos de comunicación con el alumno para el desarrollo de una vinculación afectiva y comunicativa.
- Realizar juegos en los que el maestro participe con el alumno.
- Planificar y diseñar actividades y juegos de preparación al habla que no exijan interacción verbal, pero sí comunicación corporal y producción de sonidos.
- Crear juegos con sonidos inarticulados y articulados (encadenamiento de sonidos, gradación de sonido, asociación de sonidos a movimientos,..).
- Elaborar juegos de movimiento corporal (imitación de gestos, adivinar objetos o acciones mediante mímica, dirigir a un compañero con los ojos vendados…).
- Diseñar juegos de producción de sonidos corporales (palmadas, soplidos, golpes con pies…).
- Plantear juegos de pareja que requieran emisiones verbales sencillas en cuanto a contenido y breves en cuanto a longitud (lotos, memoris, el mensaje secreto, adivinar oficios,…).
- No mantener la aplicación de una estrategia durante más de dos semanas, si ésta no ha producido progresos en el niño.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que cuando el niño padece una desaparición total del lenguaje hablado que puede ser progresiva o repentina se habla de *mutismo total*, el cual puede estar relacionado con trastornos como, por ejemplo, la depresión.

2.3.2. Afasia infantil

2.3.2.1. Conceptualización

Trastorno del lenguaje de origen cerebral SIN que haya lesión en las vías motoras o auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas, producido por una alteración del hemisferio cerebral izquierdo cuya función principal es el procesamiento del lenguaje (Chapey, 2008). Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción entre:

- Afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes traumáticos, caídas que afecten al hemisferio cerebral izquierdo). Capacidades de lenguaje previamente adquiridas, a partir de los 6 años de edad.
- Afasia congénita (mucho más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar).
- Afasia del desarrollo, también llamada disfasia.

2.3.2.2. Afasia infantil adquirida: características principales

Alteración que se presenta en un niño que ha asimilado el lenguaje y que, posteriormente, sufre una alteración del mismo corno resultado de una lesión cerebral focalizada, después de los 2 o 3 años de edad. Se sitúa, en general, entre los 2 y los 15 años, siendo las edades centrales entre los 5 y los 10 años de edad (Yáñez, 2011).

Entre sus características más importantes destacan, tal y como señalan Campos y Gimeno (2011):

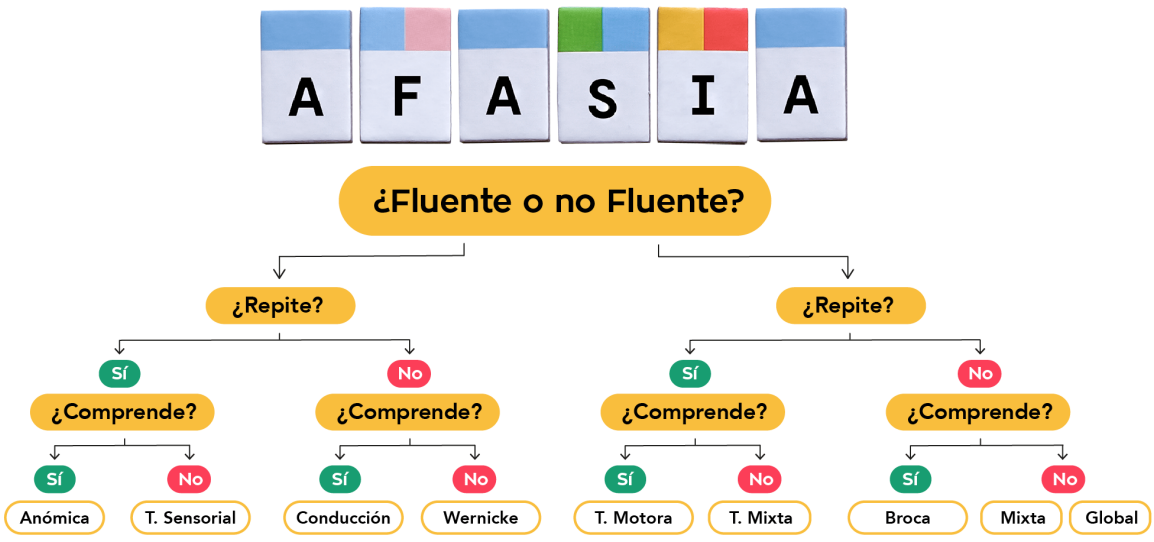
- Reducción del lenguaje espontáneo, con pobreza de vocabulario y estilo telegráfico. Ecolalias.
- Las pocas frases emitidas son articuladas de forma correcta y gramaticalmente bien construidas.
- No se presenta logorrea, las parafasias semánticas o fonémicas son raras y no hay esterotipias ni perseveraciones.
- Existe una cierta disociación automática voluntaria, conservándose el lenguaje emocional.
- La escritura está gravemente afectada.

2.3.2.3. Afasia infantil adquirida: taxonomía

En lo que respecta a su clasificación, esta se realiza teniendo en cuenta las áreas del lenguaje afectas, lo cual hace que sea considerada de triple vertiente (véase Figura 4).

Figura 4.

Clasificación de las afasias según el área del lenguaje afectada (Campos y Gimeno, 2011)



2.3.2.4. Evaluación estandarizada de la afasia infantil adquirida

Dentro de la evaluación estandarizada deben diferenciarse dos vertientes: evaluación general y evaluación específica, centrada en los componentes del lenguaje (Serrat, 1994).

- Evaluación general:
    - Prueba de Boston para el diagnóstico de afasias.
    - Batería de las Afasias de Western y Examen Multilingüe de las Afasias.
    - Prueba Minnesota para el Diagnóstico Diferencial de las Afasias.
    - Índice Porch de Habilidad Comunicativa (PICA).
- Evaluación específica:
    - Test de Denominación de Boston (BNT). Se presentan 60 figuras dibujadas en tinta negra sobre un fondo blanco para que el niño diga su nombre. Las figuras corresponden a distintas categorías (objetos, animales, instrumentos). Se dan 20 segundos para cada respuesta.
    - Test de las Fichas. Mide alteraciones de la comprensión oral y consta de cinco partes que van aumentando en dificultad.
    - Pizzamiglio. Prueba de comprensión de frases que evalúa comprensión sintáctica.
    - Test de las capacidades comunicativas en la vida diaria. Evalúa los recursos de la persona para afrontar su entorno cotidiano.
    - Prueba de Fluidez Verbal. Se deben decir en un minuto todas las palabras que comienzan por una letra particular o nombrar todos los elementos posibles que pertenecen a una categoría determinada.
    - Protocolo Pragmático. Valora 30 conductas pragmáticas que se agrupan en 4 categorías: actos expresivos, proposicionales, ilocutivos y perlocutivos.

2.3.2.5. Intervención de la afasia infantil adquirida

Como se ha trabajado, en la afasia infantil puede estar afectada la expresión (área de Broca), la comprensión (área de Wernicke) o ambas (afasia mixta).

En lo que respecta a la intervención directa, según expone Martinell (2013), se pueden hacer:

- Ejercicios de expresión:
    - Utilizar tarjetas con dibujos, cortando fotos de revistas o impresas, se le pide al niño/a que nombre los objetos de las tarjetas.
    - Hacer juegos de palabras, como decir lo contrario, o hacer una serie de preguntas si/no como «¿Se romperá el cristal?» o «¿El fuego es caliente?»

- Utilizar cualquiera de las pistas verbales o tarjetas con dibujos, se le pide al niño/a que los agrupe en categorías. Por ejemplo, con fotos de las manzanas, naranjas y plátanos. Preguntamos a qué categoría pertenecen.
- Utilizando cualquier conversación o fotos, haz preguntas de comparación. Si tienes fotos de un gato y un león, pregunta cuál es más grande.
- Nombrar objetos, sin descuidar los verbos. Para realizar la actividad, usar tarjetas verbales o imágenes, y hacer preguntas funcionales. Por ejemplo, al mostrar una imagen de una escoba, preguntar si esta sirve para barrer o para lavar.

- Ejercicios de memoria:
  - Se trata de un juego que desarrolla habilidades para la memoria. El niño/a debe memorizar las cartas que se van levantando para posteriormente unirlas, es un ejercicio de memoria. Tiene que detectar las dos cartas iguales..
  - Juegos y actividades:
  - Evocación de recuerdos, esquemas corporales, actividades de escucha, rutinas diarias, los colores…etc.
- Ejercicios de recepción:
  - Señalar la imagen que se pide: imagen que muestra una fruta o una imagen que muestra una persona triste.
  - Hacer que se indique qué objeto se utiliza para, por ejemplo, reproducir música.
  - Hacer más preguntas involucradas como, qué necesita esta persona que tiene que trabajar con este objeto, mostrarle un clavo, a continuación, imágenes de una sierra, un martillo.
  - Trabajar con las preposiciones colocando objetos en diferentes posiciones. Por ejemplo, si se tiene una caja, colocar una cuchara al lado, una detrás de ella y otro en su interior. Pedir que se apunte a la cuchara que está detrás de la caja.

Por su parte, en lo que respecta a la intervención indirecta:

- Ejercicios de discriminación auditiva, con y sin coordinación gestual.
- Ejercicios buco-faciales.

2.4. Enfermedades raras desde el marco de AL.

Las enfermedades raras constituyen un grupo heterogéneo de trastornos que, aunque presentan una baja prevalencia individual, afectando a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes en la Unión Europea, tienen un impacto significativo en el desarrollo y la calidad de vida de quienes las padecen. En conjunto, se han descrito más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales aproximadamente el 70 % son de origen genético y muchas debutan durante la infancia.



Desde el ámbito educativo, estas condiciones adquieren una especial relevancia debido a que un elevado número de ellas cursan con alteraciones en el desarrollo de la comunicación, el lenguaje, el habla y la deglución, así como con dificultades cognitivas, motoras, sensoriales o conductuales que condicionan la participación del alumnado en los contextos escolares. Sin embargo, la gran variabilidad clínica existente impide establecer un perfil lingüístico único, por lo que resulta imprescindible realizar una evaluación individualizada que permita identificar las fortalezas, necesidades y barreras comunicativas de cada estudiante.

En este contexto, el especialista en audición y lenguaje desempeña un papel esencial dentro del equipo educativo y multidisciplinar, diseñando intervenciones ajustadas a las características del alumnado, promoviendo el desarrollo de una comunicación funcional y favoreciendo la participación activa en el entorno escolar mediante estrategias de intervención basadas en la evidencia, apoyos visuales, tecnologías de apoyo y, cuando resulte necesario, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC).

Más allá del conocimiento de las características específicas de determinados síndromes, la intervención debe orientarse a potenciar las capacidades comunicativas desde un enfoque inclusivo, funcional y centrado en sus necesidades individuales, garantizando el acceso al currículo y el ejercicio de su derecho a la comunicación.

Figura 5.

Enfermedades Raras y Lenguaje (Hernández, 2010).

Enfermedades Raras y Lenguaje: cuadro - resumen

@ringhtetone

Adaptación de Hernández Fernández, A. (2010). Lenguaje en síndromes de baja incidencia. *Revista Internacional de Audición y Lenguaje, Logopedia y Apoyo a la Integración*, 1(4), 87–97.

SÍNDROME X-FRAGIL

(o Síndrome de Fraxa, FMR-1, SXF)

Alteración genética. Disc. intelectual. ⬇% mujeres.
Comorbilidad: conductas TEA⚙, otitis frecuentes, epilepsia ⚠, hiperactividad⚡.
Conductas características: "aleteos", risa inmotivada, ecolalias, timidez.

Desarrollo lingüístico:

- Aparición tardía (>3a), dificultad adquisición.
- Alteración de los órganos bucofonatorios (⬇tono muscular generalizado, errores articulatorios, maloclusión labial, ↓motricidad oral, paladar alto, babeo).
- Alteración en aspectos supra.: alteraciones del ritmo (taquilalia), voz y lenguaje perseverativo, ecolalias.

SÍNDROME DE WILLIAMS

Alteración genética. Disc. Intelectual.
Comorbilidad: aspecto facial característico, cardiopatías ❤ y otras alteraciones clínicas, retraso del crecimiento (hábitos de baño y sueño).
Procesamiento viso-espacial comprometido.
⬆D. lingüístico sobrevalora d. cognitivo.

Desarrollo lingüístico:

- Retraso en el desarrollo inicial.
- Alta sociabilidad y desinhibición.
- Buen desarrollo del habla: taquilalia.
- Vocabulario amplio y contextualizado. Preferencia por palabras de baja frecuencia.
- Buena estructuración gramatical.
- Temas restringidos y repetitivos.
- Abundancia frases hechas.
- Dificultad atencional.

SÍNDROME CORNELIA LANGE

Alteración genética peri y postnatal.
Disc. Intelectual y discapacidad auditiva.
Comorbilidad: aspecto facial característico, déficit auditivo neurosensorial, retraso psicomotor.

Desarrollo lingüístico:

- Comunicación verbal gravemente afectada.
- Poco o nulo desarrollo lenguaje oral.
- Valorar LSE como SAAC.

SÍNDROME DE PRADER WILLI

(o Síndrome de Fraxa, FMR-1, SXF)

Alteración genética. Disc. intelectual.
Comorbilidad: conductas TEA⚙, obesidad, conducta bulímica, retraso en el desarrollo.
Se caracteriza por ojos almendrados, desviación de la comisura de los labios. Conductas autoestimulatorias. Irascibilidad. Conductas restrictivas. Buena memoria a largo plazo.

Desarrollo lingüístico:

- Aparición tardía.
- Buena adquisición de vocabulario.
- Estructuración gramatical simple.
- Uso de frases hechas. Impresiona mayor nivel.
- Dislalias, hipotonía e hipernasalidad.

SÍNDROME DE TURNER

Alt. genética en mujeres. Retraso del desarrollo.
Comorbilidad: múltiples problemas médicos.

Desarrollo lingüístico:

- No necesariamente se presenta discapacidad intelectual.
- Pueden presentarse dificultades de aprendizaje asociados a la coordinación visual-motorica, matemáticas, etc.
- El lenguaje puede verse afectado en comprensión y expresión.
- Habla normal, voz forzada, hipernasalidad si fisura.

SÍNDROME DE KLINEFELTER

Alteración genética en varones. Disc. intelectual, alt, motora.

Desarrollo lingüístico:

- Adquisición lento y limitado del lenguaje.
- Dif. en lectoescritura, dislexia.
- Dif. en resolución de problemas, operaciones y razonamiento lógico-matemático limitado.
- Motricidad gruesa y fina alteradas.
- Puede presentar dificultad en diferentes dimensiones del lenguaje.

SÍNDROME DE DANDY-WALKER

Alteración genética. Disc. intelectual y motora.
Comorbilidad: cardiopatías ❤, alt. neurológicas.
Desarrollo psicomotor pobre, dificultad para movimientos en cabeza y tronco, falta de equilibrio y alteraciones en la marcha.

Desarrollo lingüístico:

- Poca o nula intencionalidad comunicativa, dif. para comprender e interactuar con el medio.
- Dificultad para establecer relaciones afectivas.
- Dificultades en lenguaje expresivo y receptivo.
- Movilidad limitada de órganos bucofonatorios.

SÍNDROME DE RETT

Alt. genética en mujeres. Disc. intelectual y motor.
Comorbilidad: conductas TEA⚙, cardiopatías❤, epilepsia ⚠, alt. neurológicas, microcefalia.
Pérdida progresiva de la movilidad. Respiratorio.
Regresión del desarrollo.

Desarrollo lingüístico:

- Adquisición temprana del lenguaje, pero con regresión.
- Empleo de SAAC con sistemas no verbales y de poco movimiento (lectores de mirada).

SÍNDROME DE MOEBIUS

Alteración genética. Disc. intelectual.
Comorbilidad: conductas TEA ⚙, visuales, otitis frecuentes, ,alt. neurológicas, características físicas (faciales), respiratorio.

Desarrollo lingüístico:

- Alteración de órganos bucofonatorios.
- Babeo excesivo, no hay reflejo de succión.
- Disglosias (/f/, /b/, /m/, /p/).

RECUERDA:
Cada alumno presenta unas necesidades individuales. Esto son orientaciones, no características rígidas.

SÍNDROME DE CRI DU CHAT

(o Síndrome de Maullido de Gato, Deleción del 5p-)

Alteración genética. Disc. intelectual.
Comorbilidad: aspecto facial característico, conductas TEA⚙, cardiopatías❤, hiperactividad⚡.
Dif. control de esfínteres.
Caracterizada en el nacimiento por ausencia de llanto o llanto monocromático, como el maullido de un gato. Mala coordinación perceptivo-motriz.

Desarrollo lingüístico:

- Aparición tardía (primeros sonidos a los 2a.).
- Atención dispersa.
- Lenguaje oral pobre. Estructuras de pocos elementos, uso funcional inmediato.
- Empleo de lenguaje no verbal (gestos).
- Sonidos guturales y, ocasionalmente, ecolalias.
- Estimulación precoz y valorar SAAC temprano.

SÍNDROME DE ANGELMAN

Alteración genética. Disc. intelectual y motórica.
Comorbilidad: conductas TEA ⚙, aspecto físico característico, ataxia y apraxia en la marcha, epilepsia ⚠.

Desarrollo lingüístico:

- Presenta interés comunicativo y suelen ser afectuosos.
- Aunque dicen algunas pocas palabras a los pocos meses, tienden a desaparecer.
- Lenguaje oral muy bajo o inexistente.
- Estructuras de uno o dos elementos.
- Nivel comprensivo alterado > expresivo.
- Dif. en deglución. Órganos bucofonatorios.

SÍNDROME DE APERT

Alt. genética. Disc. intelectual, visual y auditiva. Características físicas muy prominentes.
Comorbilidad: cardiopatías ❤, respiratorio.

Desarrollo lingüístico:

- Estimulación precoz del lenguaje, audición y sentidos.
- Establecer entornos sociales adecuados.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castello, J. A., Rigo-Carratalá, E., y Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish–Catalan children with specific language impairment (SLI). *Journal of communication disorders, 50*, 19-35.

Aguilera, S., y Busto, O. (2012). Trastornos del lenguaje. *Pediatría Integral, 16*(9), 683-90.

Ahufinger, N., Ferinu, L., Pacheco-Vera, F., Sanz-Torrent, M., y Andreu, L. (2021). El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) más allá de las dificultades lingüísticas: Memoria y atención. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 41*(1), 4-16.

Albesa, S. A., y Ayala, C. O. (2017). Trastornos del lenguaje. *Pediatría integral*, *21*(1), 15.

Artigas, J., Rigau, E., Y García-Nonell, K. (2008). *Trastornos del lenguaje*. *AEP: Protocolos de actualización*, *24*, 178-84.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5.ª ed., texto revisado).

Barragán, P. E., y Lozano, S. S. (2011). Identificación temprana de trastornos del lenguaje. *Revista Médica Clínica Las Condes, 22*(2), 227-232.

Benasich, A. A., y Tallal, P. (2002). Infant discrimination of rapid auditory cues predicts later language impairment. *Behavioral brain research, 136*(1), 31-49.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., y Catalise Consortium. (2016). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. Identifying language impairments in children. *PLOS one, 11*(7), 158-173.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Catalise-2 Consortium, Adams, C., y House, A. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58*(10), 1068-1080

Bishop, D. y Leonard, L. (2001). *Speech and language impairment in children: Causes, characteristics, intervention, and outcome*. Oxford: Psychology Press.

Campos, R. V., y Gimeno, A. M. (2011). Intervención multidisciplinar en afasias. *Instituto de Neurorehabilitación y afasia, INIA NEURAL*, *1*, 192-206.

Carboni-Román, A., del Río Grande, D., Capilla, A., Maestú, F., y Ortiz, T. (2006). Bases neurobiológicas de las dificultades de aprendizaje. *Revista de Neurología, 42*(2),171-175

Chapey, R (2008). *Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders*. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.

Hincapié, L., Giraldo-Prieto, M., Lopera-Restrepo, F., Pineda-Salazar, D. A., Castro-Rebolledo, R., Lopera-Vásquez, J. P. (2008). Trastorno Específico del Desarrollo del Lenguaje en una población infantil colombiana. *Universitas Psychologica, 7*(2), 557-569.

Lopera, F.J. (2008). Funciones ejecutivas: aspectos clínicos. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8(*1), 59-76.

López, I. R. (2019). Mutismo Selectivo. *Multimed*, *23*(4), 795-804.

Lum, J. A., Conti-Ramsden, G., Page, D., y Ullman, M. T. (2012). Working, declarative and procedural memory in specific language impairment. *Cortex, 48*(9), 1138-115.

Magdalena, D.T. (2020). *Trastorno del desarrollo del lenguaje y bilingüismo*. Trabajo de Fin de Grado, Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Recuperado de: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19742/Trastorno%20del%20Desarrollo%20del%20Lenguaje%20y%20Biling%C3%BCismo.pdf?sequence=1

Medeiro, M., & Larraguibel, M. (2018). Mutismo Selectivo: Revisión de la literatura. *Rev. Chil. Psiquiat. Neurol. Infanc. Adolesc*, *29*(2), 38-48.

Mejía-Rodríguez, D. (2015). *La influencia del retraso simple del lenguaje en el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años* (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación).

Mendoza, E., y Muñoz, J. (2005). Del trastorno específico del lenguaje al autismo. *Revista de Neurología, 41*(1), 91-98.

Montull, L., (2020). *Funciones Ejecutivas, Evaluación Dinámica y Trastorno del Desarrollo del Lenguaje: una propuesta de investigación en Educación Primaria*. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Zaragoza.

Morán, M. D. R., Vera, L. Y., y Morán, M. R. (2017). Los trastornos del lenguaje y las necesidades educativas especiales.: consideraciones para la atención en la escuela. *Revista Universidad y sociedad, 9(*3), 191-197.

Muñoz-López, J., y Carballo-García, G. (2005). Alteraciones lingüísticas en el trastorno específico del lenguaje. *Revista de neurología, 41*(1), 57-63.

Norbury, CF., Bishop, DVM., y Briscoe, J. (2001). Production of English finite verb morphology: a comparison of SLI and mild-moderate hearing impairment. *Journal Speech Language Hearing, 44*, 165-78.

Oerbeck, B., Manassis, K., Overgaard, K. R., y Kristensen, H. (2018). Mutismo selectivo. *Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP*, 1-25.

Polo, F., y Acuña, X. (2018). Estrategias didácticas para desarrollar el discurso narrativo en preescolares con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). *Revista signos, 51*(98), 410-429.

Poyuelo, M. y Rondal, J. A. (2005). *Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto*. Barcelona: Masson.

Ríos-Flórez, J. A., y López-Gutiérrez, C. R. (2017). Neurobiología de los trastornos del aprendizaje y sus implicaciones en el desarrollo infantil: propuesta de una nueva perspectiva conceptual. *Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 11*(19), 174-192.

Roselli, M, Matute, E., y Ardila, A. (2010). *Neuropsicología del desarrollo infantil*. México: Ed. Manual Moderno.

Serrat, M. M. (1994). Afasias infantiles. Revisión. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, *14*(2), 102-107.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación.* Madrid: Giunti EOS

Weismer, S. E., Tomblin, J. B., Zhang, X., Buckwalter, P., Chynoweth, J. G., y Jones, M. (2000). Nonword repetition performance in school-age children with and without language impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 43*(4), 865-878.

Yáñez, A. (2011). *Neurología Fundamental*. Santiago: Editorial Mediterráneo.

Anexo: Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL): una infografía básica actualizada. (Palazón, 2023).

